

Inseguridad alimentaria y nutricional en personas adultas mayores usuarias de centros diurnos del Gran Área Metropolitana de Costa Rica: estudio transversal con enfoque mixto

MSI. Agustín Gómez Meléndez¹, MSc. Emiliana Rivera Meza¹, MSc. Patricia Sedó Masís², Dr. Fernando Morales Martínez³, Dr. Carlos Murillo Zamora³

¹Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), Universidad de Costa Rica

²Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica

³Facultad de Medicina / Cátedra Envejecimiento y Sociedad, Universidad de Costa Rica

Resumen

Introducción: La inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN) en personas adultas mayores constituye un problema de salud pública y de derechos humanos, con consecuencias potenciales sobre fragilidad, malnutrición y deterioro del bienestar integral. Los centros diurnos de bienestar social pueden amortiguar esta vulnerabilidad, pero existe evidencia limitada sobre la INSAN en población usuaria de estos servicios en Costa Rica.

Objetivo: Estudiar factores socioeconómicos y alimentarios y su relación con la INSAN en población adulta mayor usuaria de centros diurnos atendidos por organizaciones de bienestar social del Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica durante el período 2024–2025.

Métodos: Estudio descriptivo, exploratorio y transversal con enfoque mixto. Participaron 26 centros diurnos de bienestar social, 52 personas funcionarias y 132 personas adultas mayores. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas, cuestionarios estructurados y guía de observación no participante. La INSAN se midió mediante la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) considerando los 12 meses previos a la evaluación.

Resultados: El 33,3 % (44/132) de la muestra presentó algún grado de INSAN. La INSAN moderada y severa afectó aproximadamente a una quinta parte de los participantes

(26/132; 19,7 %). La distribución por grupos etarios mostró mayor severidad relativa en el rango de 60–69 años (25 % con INSAN severa) y mayor presencia de INSAN leve en 70–79 años (20 %). Se identificaron asociaciones con escolaridad, tipo de pensión, condición de vivienda y convivencia.

Conclusiones: La prevalencia de INSAN en personas adultas mayores usuarias de centros diurnos del GAM supera las referencias nacionales reportadas para la población general. Los hallazgos respaldan el fortalecimiento de políticas públicas y la capacidad institucional de los centros diurnos para sostener apoyo alimentario continuo, especialmente para subgrupos con menor escolaridad, pensiones insuficientes y escasas redes de apoyo.

Palabras clave: inseguridad alimentaria; FIES; personas adultas mayores; centros diurnos; organizaciones de bienestar social; envejecimiento; seguridad alimentaria y nutricional.

1 Introducción

La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) se define como el derecho que tienen todas las personas, sin distinción alguna, de acceder de forma permanente y oportuna a alimentos suficientes, seguros, inocuos y nutritivos, de manera que su alimentación sea acorde con su cultura alimentaria y permita sostener una vida activa y saludable (FAO et al., 2023). Para su comprensión integral, la SAN se fundamenta en cuatro pilares interrelacionados: disponibilidad, acceso, consumo de alimentos y utilización biológica de los componentes dietéticos (Valenciano et al., 2020). Estos pilares permiten una mirada sistémica de los determinantes alimentarios y su sostenibilidad como estrategia fundamental para garantizar el derecho humano a la alimentación.

La inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN) representa la contraparte de este derecho y se refiere a la incapacidad de las personas o las familias de acceder de manera oportuna y permanente a una alimentación suficiente y adecuada, condición determinada por factores sociales, económicos, culturales y ambientales (FAO et al., 2023). A nivel global, se estima que para el año 2030 cerca de 600 millones de personas presentarán subalimentación crónica, con un ensanchamiento de las brechas entre zonas rurales y urbanas, y con mayor impacto en poblaciones vulnerables, entre ellas la población adulta mayor (FAO et al., 2023).

En la vejez, la INSAN se asocia con mayor vulnerabilidad debido a condiciones como ingresos insuficientes, limitaciones funcionales, soledad, comorbilidades crónicas y barreras físicas o cognitivas para adquirir y preparar alimentos (Tucher et al., 2021). El proceso de

envejecimiento conlleva transformaciones que afectan directamente el bienestar nutricional, incluyendo cambios fisiológicos que alteran el apetito, la absorción de nutrientes y las necesidades energéticas. La INSAN en este grupo etario incrementa el riesgo de deficiencias de nutrientes esenciales, acelera la limitación funcional y cognitiva, favorece la fragilidad e incrementa la morbilidad y mortalidad ([Ramírez et al., 2024](#); [Leung et al., 2020](#)).

Estudios realizados en diversos países latinoamericanos han documentado prevalencias elevadas de INSAN en hogares con personas adultas mayores. En México, se ha reportado que aproximadamente el 67 % de hogares con personas de avanzada edad experimentaron algún grado de inseguridad alimentaria ([Galván-Portillo et al., 2019](#); [Rivera-Márquez et al., 2014](#)), siendo esta mayor en hogares indígenas y zonas rurales. En Colombia, investigaciones recientes identificaron una prevalencia del 55 % de INSAN en hogares con personas mayores de 60 años ([Estrada-Restrepo et al., 2022](#)). En Brasil, estudios han demostrado que cerca del 63,5 % de personas adultas mayores viven en condición de inseguridad alimentaria ([Queiroz et al., 2022](#)).

En Costa Rica, la aplicación de la escala FIES a nivel nacional durante el período 2019–2020 reportó prevalencias de inseguridad alimentaria moderada o severa del 16,4 % en los hogares costarricenses durante los 12 meses previos ([Caravaca and Ugalde, 2020](#)). Un análisis posterior enfocado en hogares con población adulta mayor determinó que factores como bajos ingresos económicos, bajo nivel de escolaridad de la jefatura de hogar y residencia en ciertas regiones incrementaban la probabilidad de INSAN ([Chacón and Segura, 2021](#)). Este estudio identificó además que el 40,6 % de los hogares con personas adultas mayores que experimentaron inseguridad alimentaria se encontraban en condición de pobreza según su ingreso, y que 6 de cada 10 hogares con población adulta mayor que experimentaron INSAN no eran pobres por ingreso, evidenciando que la INSAN no está únicamente asociada con privación económica.

Los centros diurnos gestionados por organizaciones de bienestar social constituyen una red comunitaria de apoyo fundamental para personas adultas mayores, particularmente para quienes enfrentan carencias económicas o dependen de servicios de alimentación institucional ([Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2024](#)). Estas organizaciones, de carácter privado sin fines de lucro, ofrecen servicios de alimentación, actividades recreativas, ocupacionales y de estimulación física y mental durante ocho horas diarias de lunes a viernes ([Ministerio de Salud de Costa Rica, 2012](#)). Sin embargo, la evidencia específica sobre INSAN en población usuaria de centros diurnos del GAM ha sido limitada.

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar los factores socioeconómicos y alimentarios asociados a la INSAN en personas adultas mayores usuarias de centros diurnos del GAM, a partir de los hallazgos de una investigación desarrollada como Seminario de Gra-

ducción en la Universidad de Costa Rica durante 2024–2025 (Delgado Molina et al., 2025), en el marco del proyecto “Observatorio de Envejecimiento para Costa Rica” del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD).

2 Métodos

2.1 Diseño del estudio

Se realizó un estudio descriptivo, exploratorio y transversal con enfoque mixto, diseñado para caracterizar los factores socioeconómicos y alimentarios asociados a la INSAN en personas adultas mayores usuarias de centros diurnos de bienestar social del GAM. El enfoque mixto permitió integrar datos cuantitativos sobre prevalencia de INSAN y factores asociados con información cualitativa que contextualizó las experiencias y barreras en el acceso a alimentos.

2.2 Área de estudio y período

El estudio se circunscribió al Gran Área Metropolitana de Costa Rica, que comprende cantones de las provincias de San José, Heredia, Cartago y Alajuela. La recolección de datos se efectuó entre julio y octubre de 2024.

2.3 Población y muestra

La investigación consideró tres poblaciones de estudio: (i) centros diurnos de bienestar social registrados en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) ubicados en el GAM; (ii) personal funcionario de dichos centros (administración y servicio de alimentación); y (iii) personas adultas mayores usuarias de los centros participantes.

A octubre de 2024, se registraban 45 centros diurnos en las provincias correspondientes al GAM. Se contactó a la totalidad de centros mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos. Participaron finalmente 26 centros (57,8 % de los contactados), 52 personas funcionarias (dos por centro: una del área administrativa y una del servicio de alimentación) y 132 personas adultas mayores. La población total reportada en los 26 centros participantes fue de 993 personas usuarias, de las cuales el 70 % correspondía a mujeres.

2.4 Criterios de inclusión y exclusión

Para los centros diurnos se incluyeron aquellos registrados como organizaciones de bienestar social por CONAPAM y ubicados en el GAM. Se excluyeron centros con menos de cinco personas usuarias regulares o con suspensión temporal del servicio de alimentación.

Para las personas adultas mayores se incluyeron aquellas usuarias del centro diurno con asistencia regular mínima de un mes, facilidad para expresarse verbalmente, sin deterioro cognitivo referido y sin problemas auditivos que impidieran completamente la entrevista. Se excluyeron personas con condiciones médicas o emocionales que impidieran realizar la entrevista al momento de la visita.

2.5 Recolección de datos

Se planificó una visita única por centro participante. Se aplicó consentimiento informado a todos los participantes, enfatizando la voluntariedad y confidencialidad de su participación. Las técnicas de recolección incluyeron:

1. **Entrevistas semiestructuradas y cuestionarios al personal administrativo:** Se recopiló información sobre características generales del centro, población atendida, personal disponible, ingresos y gastos, y acciones de apoyo ante situaciones de vulnerabilidad alimentaria.
2. **Entrevistas semiestructuradas al personal del servicio de alimentación:** Se indagó sobre capacidad instalada, tiempos de comida ofrecidos, disponibilidad de menú, donaciones alimentarias y limitaciones operativas.
3. **Entrevistas estructuradas a personas adultas mayores:** Se aplicó un cuestionario que incluyó aspectos socioeconómicos (edad, sexo, estado conyugal, escolaridad, tipo de pensión, tenencia de vivienda, convivencia), aspectos alimentarios (preparación de alimentos en el hogar, dificultades percibidas) y la escala FIES.
4. **Observación no participante:** Mediante lista de cotejo se evaluó el estado de la infraestructura del centro (techo, paredes, pisos, cocina, comedor y bodega de alimentos).

2.6 Medición de la inseguridad alimentaria

La INSAN se evaluó mediante la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este instrumento está compuesto por ocho preguntas que evalúan experiencias

relacionadas con el acceso a alimentos y las dificultades que pueden enfrentar las personas debido a limitaciones de recursos, considerando una ventana de referencia de 12 meses previos (Caravaca and Ugalde, 2020; Garzón-Orjuela et al., 2018).

La escala permite clasificar la inseguridad alimentaria en tres niveles: leve (incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos), moderada (riesgo en cuanto a la calidad y variedad de alimentos o reducción de la cantidad consumida) y severa (cuando la persona no tiene acceso a alimentos durante un día o más) (FAO et al., 2023).

2.7 Consideraciones éticas

El estudio contó con el aval del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. Se garantizó la confidencialidad, anonimato y resguardo de datos. Toda la información recolectada queda bajo custodia del proyecto 748-C3-237 “Observatorio de Envejecimiento para Costa Rica” por un período de cinco años posteriores a la presentación del informe final.

2.8 Análisis estadístico

Se empleó estadística descriptiva para caracterizar la muestra y estimar prevalencias mediante frecuencias absolutas y relativas. Se realizaron análisis de asociación entre la INSAN y variables socioeconómicas (edad, escolaridad, tipo de pensión, condición de vivienda, convivencia) y provincia de residencia. El componente cualitativo se analizó mediante categorización temática de entrevistas y registros de observación.

3 Resultados

3.1 Caracterización de los centros diurnos participantes

Participaron 26 centros diurnos de bienestar social: 13 ubicados en la provincia de San José (50,0 %), 7 en Cartago (26,9 %), 5 en Heredia (19,2 %) y 1 en Alajuela (3,8 %). La población total atendida en estos centros fue de 993 personas adultas mayores, de las cuales 697 (70,2 %) eran mujeres y 296 (29,8 %) hombres. La Tabla 1 presenta la distribución de la población atendida según provincia y sexo.

Cuadro 1: Distribución de personas usuarias de centros diurnos participantes según provincia y sexo (julio–octubre 2024; $N = 993$).

Provincia	Hombres		Mujeres		Total	
	n	%	n	%	n	%
San José	145	49,0	312	44,8	457	46,0
Cartago	103	34,8	257	36,9	360	36,3
Heredia	40	13,5	113	16,2	153	15,4
Alajuela	8	2,7	15	2,1	23	2,3
Total	296	100,0	697	100,0	993	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en registros de centros participantes.

3.2 Caracterización sociodemográfica de la muestra de personas adultas mayores

Se entrevistó a 132 personas adultas mayores (13,3 % de la población total atendida). La mayoría de participantes tenía entre 70 y 89 años (78,8 %), con predominio del sexo femenino consistente con la distribución poblacional de los centros. La Tabla 2 presenta las características sociodemográficas de la muestra.

El 59,8 % de los participantes tenía primaria (completa o incompleta) como máximo nivel educativo. De los 132 participantes, 114 (86,4 %) reportaron recibir algún tipo de pensión, siendo el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS el más frecuente (48,2 %), seguido del Régimen No Contributivo (30,7 %). Un 34,8 % de participantes no tenía vivienda propia (alquilaban, vivían en casa prestada o en precario). Respecto a la convivencia, el 38,6 % vivía solo/a.

3.3 Prevalencia de inseguridad alimentaria

En la muestra de 132 personas adultas mayores, 44 (33,3 %) reportaron algún grado de INSAN según la escala FIES. La distribución por niveles fue: INSAN leve 18 casos (13,6 %), INSAN moderada 10 casos (7,6 %) e INSAN severa 16 casos (12,1 %). La Figura 1 ilustra esta distribución.

La prevalencia de INSAN moderada y severa combinada fue del 19,7 % (26/132), cifra superior a la referencia nacional del 16,4 % reportada para la población general de hogares costarricenses.

Nivel de INSAN	<i>n</i> (%)
Sin INSAN 	88 (66,7 %)
Leve 	18 (13,6 %)
Moderada 	10 (7,6 %)
Severa 	16 (12,1 %)

Figura 1: Distribución de participantes según nivel de INSAN ($n = 132$). Las barras son proporcionales al número de casos (escala: 1 participante $\approx$ 0,06 cm). Fuente: Elaboración propia con base en escala FIES.

3.4 Factores asociados a la inseguridad alimentaria

3.4.1 Distribución por grupos de edad

La Tabla 3 presenta la distribución de resultados FIES por rango etario. Se observó un patrón diferencial donde el grupo de 60–69 años concentró la mayor proporción de INSAN severa (25,0 % del grupo), mientras que el grupo de 70–79 años mostró mayor prevalencia de INSAN leve (19,6 % del grupo). El grupo de 80–89 años presentó la menor proporción global de INSAN (18,9 %), y en el grupo de 90 años o más no se reportó INSAN.

3.4.2 Distribución por nivel de escolaridad

Se identificó una relación inversa entre nivel educativo e INSAN. Las personas con primaria incompleta presentaron la mayor prevalencia de INSAN (51,4 % del grupo), con predominio de INSAN severa (28,6 %). En contraste, quienes tenían educación universitaria completa mostraron una prevalencia de INSAN del 12,5 %. La Tabla 4 detalla estos resultados.

3.4.3 Distribución por tipo de pensión

La prevalencia de INSAN fue marcadamente mayor entre las personas beneficiarias del Régimen No Contributivo (51,4 %) comparado con quienes recibían pensión del Régimen IVM de la CCSS (23,6 %). Entre los 18 participantes sin ningún tipo de pensión, aproximadamente el 39 % (7 personas) presentó algún grado de INSAN; de estos casos, la distribución interna fue equitativa entre INSAN leve e INSAN severa (aproximadamente 3 casos cada una), con un caso de INSAN moderada. La Tabla 5 presenta los datos correspondientes a los 114 participantes con algún tipo de pensión.

3.4.4 Distribución por condición de vivienda y convivencia

Las personas sin vivienda propia (alquiler, prestada o precario) presentaron mayor prevalencia de INSAN (rango 33–50 %) comparado con quienes tenían vivienda propia pagada. Respecto a la convivencia, de las 51 personas que vivían solas, 21 (41,2 %) reportaron INSAN moderada o severa. En contraste, entre las 81 personas que vivían acompañadas, 24 (29,6 %) reportaron algún grado de INSAN, siendo la mayoría de nivel leve. La Tabla 6 resume la distribución por ambas variables.

3.4.5 Distribución por provincia

San José fue la provincia con mayor número absoluto de casos de INSAN (24/62 participantes, 38,7 %), principalmente en niveles leve y severo. Alajuela, aunque con menor muestra (5 participantes), presentó la mayor proporción relativa de INSAN severa (20 %). Heredia registró la menor incidencia de INSAN entre las provincias estudiadas. La Tabla 7 resume estos datos.

3.5 Factores cualitativos asociados a la INSAN

El componente cualitativo del estudio permitió identificar factores adicionales reportados por personas funcionarias y participantes adultos mayores:

Entre los factores socioeconómicos destacan: dificultades económicas que limitan la adquisición de alimentos en el hogar por parte de las familias; dependencia de pensiones insuficientes (particularmente del Régimen No Contributivo con un monto de aproximadamente C\$2.000 mensuales que no ha sido revalorizado desde 2019); y necesidad de priorizar gastos básicos como alquiler y servicios sobre alimentación.

Entre los factores funcionales y de apoyo se identificaron: soledad y aislamiento social que genera desmotivación para preparar y consumir alimentos; dificultades para ejecutar tareas de compra y preparación de alimentos, especialmente en varones; problemas de salud física o emocional que afectan la alimentación; y falta de redes de apoyo familiares y comunitarias. Las personas funcionarias reportaron que los varones presentan mayores dificultades para solventar sus necesidades alimentarias en casa debido a limitadas habilidades culinarias, soledad y falta de redes de apoyo.

Respecto a las acciones institucionales de apoyo, los centros diurnos implementan diversas estrategias para apoyar a personas con vulnerabilidad alimentaria: reserva de porciones de comida cuando la persona adulta mayor está ausente por cita médica u otra razón; entrega de raciones de comida preparada para la cena (dependiendo de sobrantes); dotación de paquetes

de alimentos para consumo entre semana y fines de semana; coordinación con el Programa de la Red de Cuido para Personas Adultas Mayores (Red de Atención Progresiva para el Cuidado Integral de las Personas Adultas Mayores), centros parroquiales y asociaciones comunitarias; y apoyo económico ocasional para pasajes o gastos urgentes.

4 Discusión

Este estudio documenta una prevalencia relevante de INSAN en personas adultas mayores usuarias de centros diurnos del GAM, con un tercio de la muestra (33,3 %) reportando algún grado de inseguridad alimentaria y una quinta parte (19,7 %) en niveles moderado o severo. Esta magnitud merece atención programática y de políticas públicas, particularmente considerando que supera la referencia nacional del 16,4 % de INSAN moderada/severa reportada para la población general de hogares.

La mayor prevalencia observada en población usuaria de centros diurnos puede reflejar que estas organizaciones atienden perfiles con mayor vulnerabilidad social y económica, constituyendo precisamente su población objetivo. También evidencia que pueden existir brechas de protección alimentaria fuera del horario del servicio institucional, dado que los centros operan únicamente de lunes a viernes durante ocho horas, dejando descubiertos los fines de semana y las cenas entre semana.

La distribución por edad muestra un patrón que sugiere heterogeneidad de riesgo según el momento del curso de vida. La mayor severidad relativa en el grupo de 60–69 años (25 % con INSAN severa) puede indicar una transición vulnerable asociada al retiro reciente, con ingresos en ajuste, redes de apoyo aún inestables y posibles brechas de cobertura institucional. En contraste, la menor prevalencia en edades más avanzadas (80–89 años) podría explicarse por un efecto de supervivencia selectiva, mayor consolidación de apoyos familiares o institucionales, o selección de usuarios con mejores condiciones basales para acceder y permanecer en los centros. Estas hipótesis requieren estudios analíticos con diseños longitudinales para su verificación.

La asociación inversa entre escolaridad e INSAN coincide con hallazgos nacionales previos, donde se identificó que el 42,6 % de hogares con personas adultas mayores en condición de INSAN tenían jefaturas de hogar con primaria incompleta o menos. La escolaridad puede actuar como marcador de trayectorias laborales, acceso a pensiones contributivas y capacidades para gestionar recursos alimentarios.

El hallazgo de que las personas beneficiarias del Régimen No Contributivo presentan el doble de prevalencia de INSAN (51,4 %) comparado con quienes reciben pensión del Régimen

IVM (23,6 %) es consistente con la insuficiencia del monto de la pensión no contributiva (C82.000 mensuales) respecto al costo de la canasta básica alimentaria per cápita (C61.988 según INEC, enero 2025). Esto implica que una proporción importante de personas adultas mayores dependientes exclusivamente de esta pensión enfrentan dificultades estructurales para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas.

La relevancia de la alimentación brindada por los centros diurnos, expresada tanto por funcionarios como por usuarios, evidencia una situación de dependencia del servicio institucional. Esto sugiere la pertinencia de estrategias como: extensión de la continuidad alimentaria hacia fines de semana; fortalecimiento de la derivación a programas sociales complementarios; establecimiento de alianzas con municipalidades, organizaciones comunitarias y redes de cuido; y fortalecimiento de la capacidad operativa de los centros para sostener servicios de calidad.

4.1 Limitaciones del estudio

Este estudio presenta varias limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. Primero, se trata de un estudio exploratorio con muestreo por conveniencia, lo que limita la generalización de los hallazgos. Segundo, el estudio se circunscribió al GAM, por lo que la situación de INSAN en zonas rurales o regiones fuera del área metropolitana podría ser diferente y potencialmente más grave, considerando que estudios nacionales han identificado mayores prevalencias en regiones como la Huetar Norte, Chorotega y Pacífico Central. Tercero, el diseño transversal no permite establecer relaciones causales entre los factores identificados y la INSAN. Cuarto, la información sobre INSAN se basó en autorreporte mediante la escala FIES, lo que puede estar sujeto a sesgos de memoria o deseabilidad social.

5 Conclusiones

Se identificó una prevalencia relevante de INSAN en personas adultas mayores usuarias de centros diurnos del GAM, con un tercio de la muestra reportando algún grado de inseguridad alimentaria y una quinta parte en niveles moderado o severo. Esta prevalencia supera las referencias nacionales para la población general, lo que evidencia la vulnerabilidad particular de esta población.

Los factores asociados a la INSAN incluyen bajo nivel de escolaridad, dependencia de pensiones insuficientes (particularmente del Régimen No Contributivo), carencia de vivienda propia, vivir solo/a y residencia en ciertas provincias. Muchas situaciones de INSAN no obedecen exclusivamente a privación económica, sino también a falta de apoyo social, soledad,

limitaciones funcionales para la preparación de alimentos y deterioro de redes de apoyo.

Los centros diurnos de bienestar social constituyen una red de apoyo fundamental para esta población vulnerable. Sin embargo, sus limitaciones de horario (lunes a viernes) y de recursos dejan brechas de cobertura alimentaria que deben abordarse.

Los hallazgos respaldan el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a: (i) revalorizar el monto de la pensión del Régimen No Contributivo; (ii) ampliar la cobertura y capacidad operativa de los centros diurnos; (iii) desarrollar mecanismos de continuidad alimentaria fuera del horario institucional; (iv) fortalecer las articulaciones intersectoriales e interinstitucionales para la atención integral de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad alimentaria; y (v) desarrollar sistemas de vigilancia y monitoreo de la INSAN en esta población.

Agradecimientos

Los autores agradecen a los estudiantes Alejandro Delgado Molina, Ariana Arguedas Barboza, Daniela Arce Madriz, Kate Gordon Arrieta y Yorleny Lara Cruz, autores del Seminario de Graduación “Factores socioeconómicos y alimentarios y su relación con inseguridad alimentaria y nutricional en población adulta mayor usuaria de Centros Diurnos atendidos por organizaciones de bienestar social del Gran Área Metropolitana de Costa Rica, 2024–2025”, por su riguroso trabajo de campo y análisis. La co-autora MSc. Patricia Sedó Masís participó además como directora de dicho Seminario de Graduación.

Se agradece a la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y al Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica (ObEn) por el marco institucional del proyecto 748-C3-237. Igualmente, se extiende el agradecimiento a los 26 centros diurnos participantes, a las personas funcionarias que facilitaron las visitas y a las 132 personas adultas mayores que compartieron generosamente su tiempo y experiencias.

Financiamiento

Este estudio fue desarrollado en el marco del proyecto 748-C3-237 “Observatorio de Envejecimiento para Costa Rica”, del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIODD) en alianza con la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica.

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Referencias

- Caravaca, I. and Ugalde, F. (2020). Prevalencias de inseguridad alimentaria en Costa Rica, año 2020. Technical report, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, San José, Costa Rica.
- Chacón, K. and Segura, R. (2021). Inseguridad alimentaria afecta a población adulta mayor en hogares pobres y de baja escolaridad. Programa Estado de la Nación. <https://estadonacion.or.cr/>.
- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (2024). Registro de centros diurnos de bienestar social. CONAPAM, San José, Costa Rica.
- Delgado Molina, A., Arguedas Barboza, A., Arce Madriz, D., Gordon Arrieta, K., and Lara Cruz, Y. (2025). *Factores socioeconómicos y alimentarios y su relación con inseguridad alimentaria y nutricional en población adulta mayor usuaria de centros diurnos atendidos por organizaciones de bienestar social del Gran Área Metropolitana de Costa Rica, 2024–2025*. PhD thesis, Universidad de Costa Rica, Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina. Seminario de Graduación.
- Estrada-Restrepo, A., Giraldo-Giraldo, N. A., and Deossa-Restrepo, G. C. (2022). Inseguridad alimentaria en hogares donde habitan adultos mayores. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 40(1):e342583.
- FAO, FIDA, OMS, PMA, and UNICEF (2023). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023. Technical report, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma.
- Galván-Portillo, M., Gutiérrez-Robledo, L. M., López-García, M., and Shamah-Levy, T. (2019). Inseguridad alimentaria en adultos mayores mexicanos. *Salud Pública de México*, 61(6):735–741.
- Garzón-Orjuela, N., Melgar-Quinónez, H., and Eslava-Schmalbach, J. (2018). Escala basada en la experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) en Colombia, Guatemala y México. *Salud Pública de México*, 60(5):510–519.

- Leung, C. W., Kullgren, J. T., Malani, P. N., Singer, D. C., Kirch, M. A., Solway, E., and Wolfson, J. A. (2020). Food insecurity is associated with multiple chronic conditions and physical health status among older US adults. *Preventive Medicine Reports*, 20:101211.
- Ministerio de Salud de Costa Rica (2012). Reglamento para la habilitación de establecimientos que brindan atención a personas adultas mayores. Technical report, Ministerio de Salud. Decreto Ejecutivo No. 34728-S.
- Queiroz, F. L. N., Nakano, E. Y., Botelho, R. B. A., and Ginani, V. C. (2022). Food insecurity and nutritional status among older adults: A systematic review. *Nutrition Reviews*, 80(4):631–644.
- Ramírez, S., Quiñones, M., Palencia, F., Morales, A., Núñez, V., Castillo, D., and Yévenes, C. (2024). Efectos de la inseguridad alimentaria en población vulnerable adulta mayor: revisión rápida de literatura. Preprint, OSF.
- Rivera-Márquez, J. A., Mundo-Rosas, V., Cuevas-Nasu, L., and Pérez-Escamilla, R. (2014). Inseguridad alimentaria en el hogar y estado de nutrición en personas adultas mayores de México. *Salud Pública de México*, 56:s71–s78. Suppl 1.
- Tucher, E. L., Keeney, T., Cohen, A. J., and Thomas, K. S. (2021). Conceptualizing food insecurity among older adults: Development of a summary indicator in the National Health and Aging Trends Study. *The Journals of Gerontology: Series B*, 76(10):2063–2072.
- Valenciano, A., Pagani, L., and Álvarez, N. (2020). Seguridad y soberanía alimentaria en Costa Rica. In *Seguridad alimentaria: perspectivas regionales*. Universidad Nacional, San José, Costa Rica.

Cuadro 2: Características sociodemográficas de personas adultas mayores participantes (julio–octubre 2024; $n = 132$).

Característica	n	%
Rango de edad		
60–69 años	24	18,2
70–79 años	51	38,6
80–89 años	53	40,2
90 años o más	4	3,0
Nivel de escolaridad		
Primaria incompleta	35	26,5
Primaria completa	44	33,3
Secundaria incompleta	20	15,2
Secundaria completa	13	9,8
Universidad incompleta	12	9,1
Universidad completa	8	6,1
Tipo de pensión ($n = 114$)^a		
Régimen No Contributivo	35	30,7
Régimen IVM de la CCSS	55	48,2
Régimen Magisterio/Poder Judicial/Hacienda	15	13,2
Otro/No sabe	9	7,9
Condición de vivienda		
Vivienda propia (pagada)	86	65,2
Vivienda en alquiler	23	17,4
Vivienda prestada	17	12,9
Precario/Otra	6	4,5
Convivencia		
Vive solo/a	51	38,6
Vive acompañado/a	81	61,4

^aSe excluyen 18 participantes sin pensión.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a participantes.

Cuadro 3: Distribución de resultados FIES según rango de edad (julio–octubre 2024; $n = 132$).

Rango de edad	Nivel de INSAN				Total	% INSAN
	Leve	Moderada	Severa	No presenta		
60–69 años	3	1	6	14	24	41,7
70–79 años	10	8	6	27	51	47,1
80–89 años	5	1	4	43	53	18,9
90 años o más	0	0	0	4	4	0,0
Total	18	10	16	88	132	33,3

Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de escala FIES.

Cuadro 4: Distribución de resultados FIES según nivel de escolaridad (julio–octubre 2024; $n = 132$).

Escolaridad	Nivel de INSAN				Total	% INSAN
	Leve	Moderada	Severa	No presenta		
Primaria incompleta	5	3	10	17	35	51,4
Primaria completa	11	6	4	23	44	47,7
Secundaria incompleta	1	0	1	18	20	10,0
Secundaria completa	0	0	1	12	13	7,7
Universidad incompleta	1	0	0	11	12	8,3
Universidad completa	0	1	0	7	8	12,5
Total	18	10	16	88	132	33,3

Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de escala FIES.

Cuadro 5: Distribución de resultados FIES según tipo de pensión (julio–octubre 2024; $n = 114$).

Tipo de pensión	Nivel de INSAN				Total	% INSAN
	Leve	Moderada	Severa	No presenta		
Régimen No Contributivo	5	5	8	17	35	51,4
Régimen IVM de la CCSS	8	2	3	42	55	23,6
Magisterio/P. Judicial/Hacienda	2	2	0	11	15	26,7
Otro/No sabe	0	0	2	7	9	22,2
Total	15	9	13	77	114	32,5

Nota: Se excluyen 18 participantes sin pensión (39 % con algún grado de INSAN; véase texto).

Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de escala FIES.

Cuadro 6: Distribución de prevalencia de INSAN según condición de vivienda y convivencia (julio–octubre 2024; $n = 132$).

Variable	n	% INSAN	Nivel predominante	Observación
Condición de vivienda				
Vivienda propia (pagada)	86	—	—	Referencia
Sin vivienda propia ^a	46	33–50	Variable	Mayor vulnerabilidad
Alquiler	23	≥ 33		
Prestada	17	≥ 33		
Precario	6	≥ 33		
Convivencia				
Vive solo/a	51	$\geq 41,2^b$	Moderada/severa	
Vive acompañado/a	81	29,6	Leve	
Total	132	33,3		

^aSuma: alquiler ($n = 23$) + prestada ($n = 17$) + precario ($n = 6$). El desglose completo por nivel de INSAN requiere consulta del dataset original (Delgado Molina et al., 2025).

^bPorcentaje de INSAN moderada o severa; el total incluyendo nivel leve es superior.

Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de escala FIES.

Cuadro 7: Distribución de resultados FIES según provincia de residencia (julio–octubre 2024; $n = 132$).

Provincia	Nivel de INSAN				Total	% INSAN
	Leve	Moderada	Severa	No presenta		
San José	10	6	8	38	62	38,7
Alajuela	0	2	1	2	5	60,0
Cartago	5	1	4	25	35	28,6
Heredia	3	1	3	23	30	23,3
Total	18	10	16	88	132	33,3

Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de escala FIES.